

TEMA 6.10 • INFECTOLOGÍA

Amigdalitis, Difteria y Anginas Infecciosas

PERFIL EUNACOM 1.05.1.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Amigdalitis: Bacteriana vs. Viral, Difteria y Angina de Vincent

Diagnóstico Diferencial

TABLA 6.10.1: CARACTERÍSTICA VS BACTERIANA (STREPTOCOCCUS PYOGENES = GRUPO A)		
CARACTERÍSTICA	BACTERIANA (STREPTOCOCCUS PYOGENES = GRUPO A)	VIRAL
Inicio	Súbito	Gradual
Odinofagia	Intensa	Moderada
Fiebre	Alta (39-40°C)	Variable
Exudado	Blancoamarillento en surcos amigdalinos	Exudado blanco superficial y adherente (EBV)
Síntomas catarrales	AUSENTES (sin tos, rinorrea, disfonía)	PRESENTES
Conjuntivitis	No	Posible (adenovirus: fiebre faringoconjuntival)
Hemograma	Neutrofilia	Linfocitosis

EUNACOM CRITERIOS

Rash morbiliforme en mononucleosis (EBV). Rash escarlatiniforme en bacteriana (Scarlatina). Amoxicilina/ampicilina amplifica el rash de EBV hasta el 90%.

Tratamiento de la Amigdalitis Bacteriana

TABLA 6.10.2: OPCIÓN VS FÁRMACO			
OPCIÓN	FÁRMACO	DOSIS	DURACIÓN
1ª línea	Penicilina Benzatínica IM	1.200.000 UI (< 30 kg: 600.000 UI)	Dosis única
Alternativa oral	Amoxicilina	Dosis estándar	10 días
Alérgico a Penicilina	Azitromicina	500 mg/día	5 días
Alternativa	Eritromicina, Claritromicina	—	10 días
Alternativa	Clindamicina, Cefalexina	—	10 días

> El tratamiento no mejora la enfermedad, previene las complicaciones: **Fiebre Reumática, GNAPE**.

Complicaciones / Abscesos

- **Absceso periamigdalino:** Trismus (imposibilidad de abrir la boca), gondolamiento del pilar.
- **Absceso parafaríngeo:** Dolor cervical a los movimientos laterales.
- **Absceso retrofaríngeo** (el más grave): Dolor cervical a movimientos anteroposteriores.
- **Manejo:** TAC de cuello + ATB amplio espectro + **Drenaje quirúrgico**.

- Puede disecarse al mediastino → **Mediastinitis aguda** (sepsis grave, dolor torácico): urgencia quirúrgica.

Difteria

- **Agente:** *Corynebacterium diphtheriae* (bacilo Gram positivo). Erradicada por vacuna.
- **Clínica específica:** Orofaringe con **seudomembranas** blancogrisas adherentes + edema cervical masivo ("cuello de toro").
- **Complicaciones:** Miocarditis, necrosis tubular aguda (mortal).
- **Tratamiento:** Penicilina G o Macrólidos + **Antitoxina antidiférica** (imprescindible).

Angina de Vincent (Angina Ulceronecrótica)

- **Agente:** Anaerobios de la cavidad oral.
- **Clínica:** Amigdalitis ulceronecrótica + gingivitis severa + **alitisos intensa** + úlceras que pueden necrosar el paladar/amígdalas.
- **Diferencia de Difteria:** Sseudomembranas menores; úlceras y necrosis más prominentes.
- **Tratamiento:** Agua oxigenada (anaerobios mueren con oxígeno) + **Metronidazol** o Clindamicina.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 8 años consulta por odinofagia intensa de inicio súbito, fiebre de 39,5°C y exudado blanco grisáceo en surcos amigdalinos, sin tos ni rinorrea. Refiere alergia a penicilina (exantema). ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amigdalitis, Difteria y Anginas Infecciosas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amigdalitis bacteriana (10%): Streptococcus pyogenes, odinofagia intensa de inicio súbito, fiebre alta, exudado en surcos amigdalinos, SIN síntomas catarrales.
- Tratamiento de elección: penicilina benzatina 1,2 millones IM (o amoxicilina oral 10 días). En alérgicos: azitromicina, clindamicina o cefadroxilo.
- Complicaciones inmunes: GNAPI y fiebre reumática. Complicaciones bacterianas: abscesos (periamigdalino el más frecuente con trismus, retrofaríngeo el más grave).
- Amigdalitis viral (90%): síntomas catarrales (tos, rinorrea, disfonía), tratamiento sintomático.
- Difteria: erradicada en Chile (vacuna), pseudomembranas faríngeas, cuello de toro, complicaciones cardíacas y renales. Tratamiento: penicilina/macrólidos + antitoxina.
- Angina de Vincent: infección por anaerobios, gingivitis severa, halitosis marcada, úlceras necróticas. Tratamiento: agua oxigenada + metronidazol/clindamicina.
- Hemograma: linfocitosis orienta a viral, neutrofilia orienta a bacteriana. Exantema escarlatiniforme = bacteriana; rash morbiliforme = mononucleosis.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMIGDALITIS, DIFTERIA Y ANGINAS INFECCIOSAS)

PREGUNTA 1

Paciente de 8 años consulta por odinofagia intensa de inicio súbito, fiebre de 39,5°C y exudado blanco grisáceo en surcos amigdalinos, sin tos ni rinorrea. Refiere alergia a penicilina (exantema). ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A) Tratamiento sintomático con paracetamol
- B) Ceftriaxona intramuscular
- C) Azitromicina oral por 5 días
- D) Amoxicilina-ácido clavulánico por 10 días
- E) Ciprofloxacino oral por 7 días

PREGUNTA 2

Paciente de 25 años con antecedente de amigdalitis pultácea hace 5 días, ahora con imposibilidad de abrir la boca, fiebre persistente y abombamiento del pilar faríngeo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

- A) Absceso retrofaríngeo; antibióticos de amplio espectro y drenaje quirúrgico
- B) Absceso periamigdalino; antibióticos de amplio espectro y drenaje quirúrgico
- C) Mediastinitis aguda; antibióticos endovenosos urgentes
- D) Angina de Vincent; enjuagues con agua oxigenada y metronidazol
- E) Difteria; penicilina más antitoxina

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes características clínicas diferencia mejor una amigdalitis viral de una bacteriana?

- A) Presencia de fiebre alta
- B) Presencia de adenopatías cervicales
- C) Presencia de síntomas catarrales (tos, rinorrea, disfonía)
- D) Presencia de odinofagia
- E) Presencia de eritema faríngeo

RESUMEN: AMIGDALITIS, DIFTERIA Y ANGINAS INFECCIOSAS

Esta clase aborda la diferenciación entre amigdalitis bacteriana y viral, junto con la difteria y las anginas infecciosas. La amigdalitis bacteriana (10% de los casos) es causada por *Streptococcus pyogenes* (grupo A) y se caracteriza por odinofagia intensa de inicio súbito, fiebre alta, exudado blanco grisáceo en surcos amigdalinos, adenopatías cervicales y ausencia de síntomas catarrales. El gold standard diagnóstico es el cultivo faríngeo y el tratamiento de elección es penicilina benzatina 1,2 millones IM (o amoxicilina oral por 10 días). Las complicaciones incluyen las inmunes (glomerulonefritis aguda postestreptocócica y fiebre reumática) y las bacterianas (abscesos periamigdalino, parafaríngeo y retrofaríngeo), que pueden evolucionar a mediastinitis aguda. El absceso periamigdalino es el más frecuente y se caracteriza por trismus y abombamiento del pilar faríngeo. La amigdalitis viral (90% de los casos) se distingue por la presencia de síntomas catarrales (tos, rinorrea, disfonía) y se trata sintomáticamente. La difteria, erradicada en Chile gracias a la vacuna, es causada por *Corynebacterium diphtheriae* y se caracteriza por pseudomembranas faríngeas y cuello de toro. La angina de Vincent es una infección faríngea por anaerobios con gingivitis severa, halitosis marcada y úlceras necróticas, tratada con agua oxigenada y metronidazol o clindamicina.